UT 2 · DOCUMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN DE AUTOPSIAS · CURSO 26-27

DECÁLOGO NORMATIVO Y DOCUMENTAL DE AUTOPSIAS

Guía operativa de legislación, gestión documental y bioseguridad para el Técnico Especialista

1. AUTOPSIA CLÍNICA (RD 2330/1982)

- **Responsable:** Médico anatomopatólogo
- **Centros:** Hospitales acreditados / Salud Púb.
- **Requisito:** Autorización familiar y M. Certificada
- **Costes:** Asumidos 100% por el hospital

2. AUTOPSIA JUDICIAL (LECrim / IML)

- **Ordena:** Juez de Instrucción (sin permiso fam.)
- **Ejecuta:** Cuerpo Nacional Médicos Forenses
- **Sedes IML Canarias:** Tenerife y Gran Canaria
- **Clave:** Levantamiento e identificación previa

3. PRELACIÓN Y PARENTESCO CIVIL

- **Cónyuge / Pareja:** Prioridad directa
- **1.er Grado Consang.:** Padres e hijos
- **1.er Grado Afinidad:** Suegros, yernos/nueras
- **2.º Grado:** Hermanos, abuelos, nietos, cuñados

Figura 1. Síntesis comparativa del régimen jurídico de las autopsias en España y grados de parentesco para autorización.

I. MARCO REGULADOR: AUTOPSIA CLÍNICA, JUDICIAL Y ESPECIALES (PUNTOS 01 – 05)

01. Centros autorizados e instalaciones clínicas (Ley 29/1980 y RD 2330/1982, Arts. 1, 2 y 4): Las autopsias clínicas solo se practican en hospitales con servicio de Anatomía Patológica, salas dotadas de equipamiento y personal o centros adscritos, salvo excepción dictada por salud pública. Deben disponer de sala de autopsias, cámaras frigoríficas, aseos con duchas de agua fría y caliente, secretaría, laboratorio histopatológico y archivo de piezas, preparaciones, informes y fotografías. El hospital asume siempre los estudios y el traslado del cadáver, nunca la familia.

02. Responsabilidad facultativa y régimen de autorización familiar (RD 2330/1982, Arts. 3 y 5; Código Civil): El médico anatomopatólogo es el responsable total del proceso. En fallecidos hospitalarios se requiere autorización vía Ministerio de Sanidad, ausencia de oposición familiar y el compromiso de no desfigurar el cuerpo ni comercializar vísceras. Fuera del hospital (si supone desfiguración), es obligatoria la autorización expresa del cónyuge o familiares de **primer grado** (no cualquier familiar puede firmar sin respetar la prelación legal: 1.er grado padres/hijos y suegros/yernos/nueras; 2.º grado hermanos/abuelos/nietos).

03. Autopsia medicolegal o judicial e Institutos de Medicina Legal (LECrim, Arts. 343, 349, 353 y 778; RD 386/1996): Se ejecuta por orden del juez de instrucción en muertes violentas o sospechosas de criminalidad, siendo irrelevante el permiso familiar. La realizan los médicos forenses (RD 296/1996) en los **IML** (actualizados por RD 144/2023), órganos técnicos que auxilian a juzgados, tribunales, fiscalías y Registro Civil con servicios de patología, clínica (peritajes) y laboratorio forense (biología y tóxicos). En Canarias operan dos sedes centrales: Tenerife (provincia occidental) y Gran Canaria (provincia oriental).

04. Levantamiento del cadáver y armonización metodológica europea (Recomendación n.º R (99) 3 del Consejo de Europa): En muertes no naturales, la autoridad acude a la escena con la policía y el perito medicolegal para examinar el cuerpo y el lugar. En la autopsia intervienen dos médicos (al menos uno especialista en patología forense): es prioritaria la **identificación del cadáver**, seguida de la toma de muestras en orificios naturales, el examen externo y el estudio interno detallado de cavidades, volumen de sangre/fluidos, órganos, lesiones, hemorragias y disección del cuello.

05. Actuación forense ante catástrofes con múltiples víctimas (Real Decreto 32/2009, de 16 de enero): El Protocolo Nacional coordina a los médicos forenses (IML e INTCF) y a la Policía Científica en grandes siniestros, regulando el levantamiento cuadriculado, la toma de muestras necroidentificativas (huellas, odontograma, radiología y ADN) y el cruce de formularios *Ante Mortem* y *Post Mortem*.

II. POLICÍA MORTUORIA, DOCUMENTACIÓN, CALIDAD Y BIOSEGURIDAD (PUNTOS 06 – 10)

06. Policía Sanitaria Mortuoria (Decreto 2263/1974 y reglamentos autonómicos): Regula desde la salud pública las prácticas sanitarias sobre cadáveres (obtención de piezas/tejidos, conservación temporal, embalsamamiento, tanatopraxia y estética) y supervisa las condiciones técnico-sanitarias de las funerarias en el transporte nacional/internacional, féretros e incineraciones.

07. Verificación estricta de la documentación previa obligatoria (RD 2330/1982, Art. 6 y LECrim): Si falta algún documento previo o contiene errores, **no puede iniciarse la autopsia**. En la autopsia clínica, la autorización consta de tres hojas autocalcables (historia clínica, anatomía patológica y familiar) y se entrega a la familia copia del certificado médico especial de muerte cierta.

08. Registro en sala, informes finales y aprovechamiento científico (RD 2330/1982, Arts. 6 y 7): Toda la documentación se registra en el **libro de autopsias** de la sala. El anatomopatólogo decide la técnica de apertura y remite los informes al médico o jefe de servicio para emitir el Certificado Médico de Defunción (modelo OMC), quedando los diagnósticos disponibles para docencia, estadística y publicaciones científicas preservando la intimidad familiar.

09. Calidad, trazabilidad y cadena de custodia (UNE-EN ISO 15189 / ISO 17020 / Orden JUS/1291/2010): El técnico asegura la trazabilidad inequívoca de cadáveres, botes, bloques de parafina, preparaciones y archivos. En muestras forenses remitidas al INTCF, se documenta rigurosamente la cadena de custodia desde la toma hasta el análisis pericial.

10. Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y protección ambiental (Ley 31/1995, RD 664/1997, RD 665/1997 y Ley 7/2022): Uso obligatorio de EPI frente a agentes biológicos (mascarilla FFP2/FFP3 al usar sierra oscilante por aerosoles, pantalla facial, delantal impermeable y guante anticorte) y ducha en el centro; extracción localizada en mesa y sala frente al formaldehído (carcinógeno) y xilol; segregación de cortopunzantes y biorresiduos en contenedores rígidos (Grupo III) y retirada de reactivos químicos mediante gestor autorizado.

Modalidad	Documentación Previa Imprescindible (Cuadro 2.1)	Cierre y Registro
Autopsia Clínica	• Autorización familiar (3 hojas autocalcables) · Certificado de muerte cierta o defunción · Certificado de autorización de estudio necrópsico (con consentimiento informado) · Hoja de petición de estudio autópsico · Resumen de historia clínica.	Inscripción en libro de autopsias · Informe a jefe de servicio · Certificado Defunción (OMC).
Autopsia Judicial	• Orden judicial emitida por el juzgado de instrucción competente (no existe autorización familiar).	Informe pericial forense al juez · Licencia de enterramiento.
Autopsia Fetal	• Petición de autopsia · Hoja de autorización familiar · Fotocopia del certificado de defunción o registro de fetos · Hoja de datos clínicos · Historial o antecedentes familiares.	Inscripción en libro de autopsias · Informe anatomopatológico perinatal.

GLOSARIO TÉCNICO, JURÍDICO Y SIGLAS

- **Diagnósticos primarios:** Integran la *causa básica/inicial* (enfermedad o lesión que inició la cadena patológica letal), la *causa intermedia* (condición contribuyente, si existe) y la *causa inmediata/directa* (produce finalmente la muerte).
- **Patología secundaria vs. accesoria:** La *secundaria* deriva de la principal sin causar la muerte; la *accesoria* existía previamente y no influyó en el fallecimiento.
- **Autopsia blanca:** Aquella con información clínica o de

FUENTES OFICIALES VERIFICABLES (BOE / UE)

1. **Ley 29/1980 y RD 2330/1982** (Autopsias clínicas): **boe.es/eli/es/rd/1982/06/18/2330**
2. **LECrim** (Arts. 343, 349, 353, 778): **boe.es/eli/es/rd/1882/09/14/(1)/con**
3. **RD 386/1996 y RD 296/1996** (Reglamento IML y Médicos Forenses): **boe.es/eli/es/rd/1996/03/01/386**